

《[문제10.3]

<사례>

IT 기업 B사에서 소프트웨어 개발자로 근무하는 근로자 甲은 신규 프로젝트 출시를 앞두고 3개월 동안 만성적인 과로에 시달렸다. 甲은 사고 발생 직전 12주 동안 1주 평균 62시간을 근무하였으며 사고 직전 1주일 동안은 업무량이 급증하여 평소보다 30퍼센트 이상 업무 시간이 증가하였다. 또한 프로젝트 완료 보고회를 하루 앞둔 시점에 프로그램 결함이 발견되어 극도의 긴장 상태에서 밤샘 작업을 수행하던 중 뇌출혈로 쓰러져 의식을 잃었다. 한편 같은 회사의 마케팅팀 근로자 乙은 직속 상사인 팀장으로부터 지속적인 폭언과 무시를 당해왔다. 팀장은 회의 석상에서 乙에게 인격 모독적인 발언을 서슴지 않았으며 업무와 무관한 사적 심부름을 강요하고 이를 거부할 경우 업무 성과 평가에서 최하점을 주겠다고 협박하였다. 이로 인해 乙은 심각한 불면증과 우울감을 호소하다 결국 전문의로부터 적응장애 및 우울증 진단을 받았다. 乙은 평소 기저질환이 없었으며 가정 환경이나 개인적 신상에도 특별한 문제가 없었다.

(물음1) 근로자 甲의 뇌출혈이 업무상 질병으로 인정되기 위한 판단 기준을 뇌심혈관계 질환의 업무상 질병 인정 기준(만성 과로 및 단기 과로 등)에 근거하여 논하시오. (25점)》

<문제10.3의 물음1> 근로자의 만성 과로 및 단기 과로에 따른 뇌출혈의 업무상 질병 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 발병 전 12주간의 평균 업무 시간이 고시 기준을 상회하는 만성 과로 상태였으며, 발병 직전 업무량이 급증한 단기 과로와 밤샘 작업이라는 예측 곤란한 돌발 상황이 중첩되어 나타났다. 쟁점으로 뇌심혈관계 질환의 구체적 판단 기준인 급성 과로, 단기 과로, 만성 과로의 법리를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이를 甲의 사례에 적용하여 업무상 질병 인정 여부를 논한다.

II. 뇌심혈관계 질환의 업무상 질병 인정 기준

1. 급성 과로 (돌발적 사건 또는 급격한 업무 환경 변화)

(1) 의의

- 중상 발생 전 24시간 이내에 업무와 관련된 돌발적이고 예측 곤란한 사건이 발생하거나 급격한 업무 환경의 변화로 뇌혈관 또는 심장혈관의 병변 등이 급격히 악화된 경우를 말한다.

(2) 판단 요소

- 갑작스러운 놀람, 분노, 공포 등 정신적 충격을 급격히 유발하는 사건이나, 평소의 업무 범위를 크게 벗어나는 극한의 육체적 노동 등이 포함된다. 사안의 경우 보고회를 하루 앞두고 발견된 프로그램 결함과 그에 따른 밤샘 작업이 이에 해당할 수 있다.

2. 단기 과로 (업무량 및 업무 시간의 급격한 증가)

(1) 의의

- 발병 전 1주일 이내의 업무 양이나 시간이 이전 12주일간(발병 전 1주일 제외)의 1주 평균보다 30퍼센트 이상 증가한 경우를 의미한다.

(2) 판단 내용

- 업무의 양·시간·강도·책임 및 휴무 시간 등이 종합적으로 고려된다. 甲의 경우 사고 직전 1주일간 업무 시간이 평소보다 30퍼센트 이상 증가하였다는 점에서 단기 과로 요건을 명확히 충족한다.

3. 만성 과로 (장기간의 과중한 업무)

(1) 의의

- 발병 전 12주일 동안 업무 양과 시간이 만성적으로 과중하여 뇌혈관 등의 정상적인 기능에 뚜렷한 영향을 줄 수 있는 부하를 준 경우를 말한다.

(2) 시간제 요건 (고용노동부 고시 기준)

- ① 발병 전 12주일 동안 1주 평균 업무 시간이 60시간(4주간 1주 평균 64시간)을 초과하는 경우 업무와 질병 사이의 관련성이 강하다고 평가한다.
② 1주 평균 업무 시간이 52시간을 초과하는 경우에는 업무 부담 가중요인(교대제 근무, 휴일 부족, 정신적 긴장이 큰 업무 등)이 복합적으로 작용할 때 관련성이 강한 것으로 본다.

III. 업무 부담 가중요인의 고려

1. 정신적 긴장 수반 업무

- 소프트웨어 개발 업무와 같이 정해진 기한(Dead-line) 내에 성과를 내야 하거나, 프로그램 결함 해결과 같이 고도의 집중력과 정신적 긴장을 요하는 업무는 뇌혈관 질환에 부정적인 영향을 미치는 주요 가중요인으로 작용한다.

2. 수면 부족과 밤샘 작업

- 야간 근무나 밤샘 작업은 생체 리듬을 파괴하고 혈압 상승을 유발하여 질병 발생의 위험을 급격히 높인다. 특히 사고 직전의 밤샘 작업은 혈관의 급격한 수축과 압력 증가의 직접적인 원인이 될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 만성 과로 여부

- 甲은 사고 발생 직전 12주 동안 1주 평균 62시간을 근무하였다. 이는 고용노동부 고시가 정한 강한 관련성 기준인 주 60시간을 초과한 것으로서, 장기간에 걸친 과로가 甲의 건강 상태를 서서히 악화시켰음을 추단할 수 있는 객관적 지표가 된다.

2. 단기 과로 및 급격한 업무 변화

(1) 업무량의 급증

- 사고 직전 1주일 동안 업무 시간이 평소보다 30퍼센트 이상 증가한 사실이 확인된다. 이는 단기 과로 인정 기준에 부합하며, 신체가 적응하기 어려운 수준의 업무 부하가 단기간에 집중되었음을 의미한다.

(2) 돌발적 상황과 밤샘 작업

- 프로젝트 완료 보고회 직전의 프로그램 결함 발견은 예측 곤란한 돌발 사건에 준하며, 이를 해결하기 위한 밤샘 작업은 극도의 긴장 상태를 유발하였다. 이는 24시간 이내의 급성 과로 요건과도 밀접한 관련이 있다.

3. 인과관계의 종합 판단

- 甲은 12주간의 만성 과로로 인해 신체적·정신적 예비 능력이 저하된 상태에서, 사고 직전 1주일간의 단기 과로와 사고 직전 24시간 이내의 급성 과로(밤샘 및 긴장)가 중첩되어 뇌출혈이 발병하였다. 고혈압이나 당뇨 등 甲의 기초 질환 유무에 대한 언급은 없으나, 설령 기저질환이 있었다 하더라도 이러한 수준의 업무 부하는 질병을 자연적인 경과 이상으로 급격히 악화시키기에 충분한 것으로 판단된다.

V. 결론

- 근로자 甲의 뇌출혈은 산업재해보상보험법 및 관련 고시에서 정한 업무상 질병 인정 기준을 모두 충족한다. 1주 평균 62시간의 만성 과로, 직전 1주일간 30퍼센트 이상의 업무 증가라는 단기 과로, 그리고 보고회 전날의 결함 발견과 밤샘 작업이라는 급격한 업무 환경 변화가 복합적으로 작용하여 발병한 것이 명백하므로, 甲의 질병은 업무와 상당인과관계가 있는 업무상 질병으로 인정된다.